

콜레스테롤이 정상인데 왜 심장이 위험할까요?

잘 알려지지 않은 심혈관 위험인자 — 지질단백질(a), 즉 Lp(a) 이야기

Lp(a)가 무엇인가요

나쁜 콜레스테롤(LDL)에 끈끈한 단백질이 한 겹 더 붙은, 특별한 형태의 지질입니다

Lp(a)는 LDL 입자에 **아포(a)**라는 끈끈한 단백질이 추가로 붙어 있는 형태로, 혈관에 더 잘 들러붙고 혈전과도 관련됩니다.

보통의 콜레스테롤 검사(LDL·HDL·중성지방)에는 나오지 않아 따로 측정해야 알 수 있습니다. 농도는 주로 타고난 유전으로 정해져 평생 비교적 일정하며, 식사·운동으로는 크게 바뀌지 않습니다. 그래서 "콜레스테롤은 정상인데 심장병이 일찍 온" 경우의 숨은 원인이 되기도 합니다.

유전으로 결정

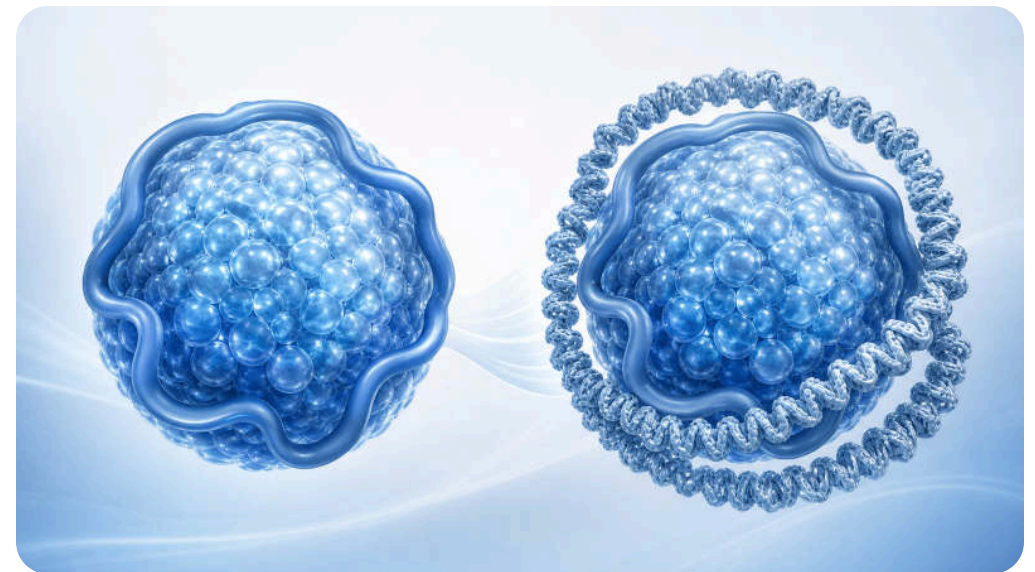
평생 일정

농도의 약 70~90%가 유전 —
식이·운동으로는 거의 바뀌지
않습니다.

일반 검사엔 없음

따로 측정

혈액검사로 Lp(a) 항목을 추가해야
확인할 수 있습니다.



왜 위험할까요

VESALIUS-CV 연구에서 Lp(a)가 높을수록 심장 혈관 사건이 늘었습니다

관상동맥 사건

위험 약 15% 증가

Lp(a)가 100nmol/L 높아질 때마다 주요 관상동맥 사건(심장사·심근경색·응급 시술)이 약 15% 늘었습니다. (위험비 1.15)

심근경색 (MI)

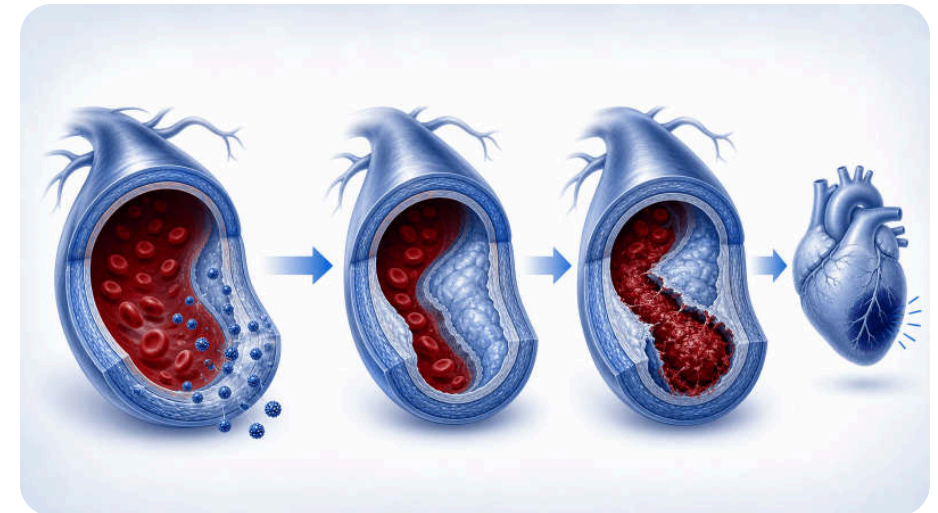
위험 약 23% 증가

심근경색만 떼어 보면 100nmol/L 증가당 위험이 약 23% 더 높았습니다. (위험비 1.23) 심장 혈관에 특히 영향이 컸습니다.

허혈성 뇌졸중

뚜렷한 관련 없음

반면 뇌졸중과는 의미 있는 연관이 보이지 않았습니다. (위험비 1.00) Lp(a)는 주로 심장 혈관 위험과 연결됩니다.



누구를, 얼마나 오래 관찰했나요

아직 심근경색·뇌졸중을 겪지 않은 고위험군에서 Lp(a)를 측정해 추적했습니다

7,557명

VESALIUS-CV 연구에서 기저 Lp(a)를 측정한 참가자 수 — 중앙 추적 기간은 4.6년입니다.

WHO & HOW LONG

대상은 심근경색·뇌졸중 **기왕력이 없는** 고위험자, 즉 **1차 예방** 대상입니다. 중앙 연령은 66세, 여성이 42.8%였고, 혈중 Lp(a) 중앙값은 28nmol/L였습니다. 이 연구는 평소 잘 다루지 않던 Lp(a)가 실제 심장 사건과 어떻게 연결되는지를 본 것입니다.

콜레스테롤 강하 치료의 효과

강력한 LDL 강하 주사제(에볼로쿠맙)는 두 그룹 모두에서 심장 사건을 줄였습니다

LP(A)가 높은 그룹

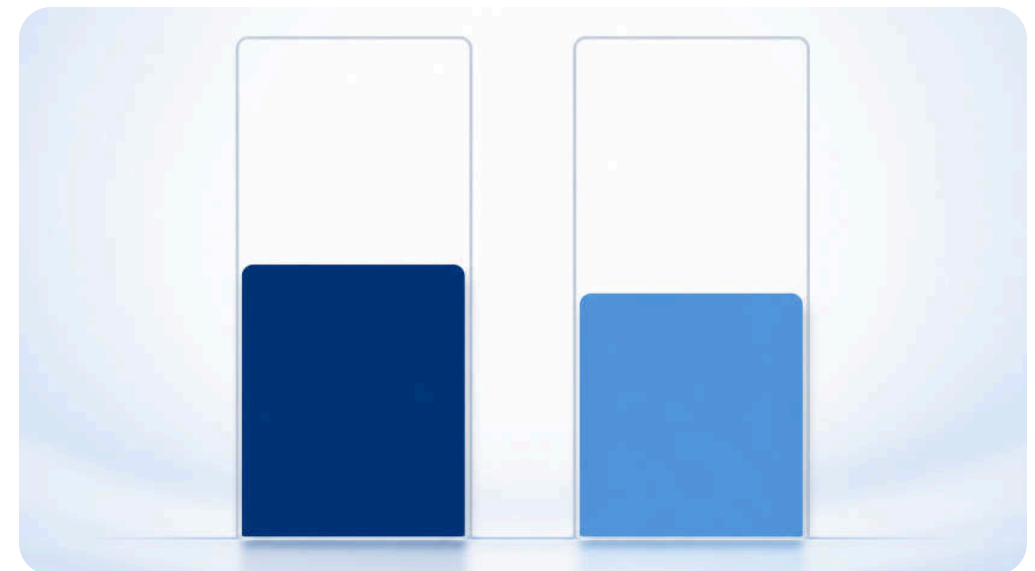
관상동맥 사건 약 41% 감소

기저 Lp(a)가 높았던(105nmol/L 초과)
참가자에서 치료군의 주요 관상동맥
사건이 약 41% 줄었습니다. **(위험비 0.59)**

LP(A)가 낮은 그룹

관상동맥 사건 약 35% 감소

Lp(a)가 낮았던(105nmol/L 이하)
참가자에서도 사건이 약 35%
줄었습니다. **(위험비 0.65)** 양쪽 모두
분명한 이득이 있었습니다.



"Lp(a)가 높으면 약 효과가 더 좋다"고 말할 수 있을까요

숫자만 보면 그래 보이지만, 통계적으로는 아직 단정할 수 없습니다

한 명의 사건을 막기 위해 치료가 필요한 인원(NNT)은
Lp(a) 높은 그룹 약 28명, 낮은 그룹 약 40명으로
차이가 있어 보였습니다.

하지만 두 그룹의 효과 차이가 우연이 아니라고 보기엔 통계가 충분하지 않았습니다 (상호작용 $p=0.45$, 절대감소 차이 $p=0.09$ — 모두 유의 기준 미달). 게다가 이 분석은 미리 정해 둔 하위그룹 가설탐색이며, Lp(a)를 직접 낮춰 사건이 줄었는지를 본 연구도 아닙니다. 그래서 "Lp(a) 높은 사람만 약효가 좋다"고 단정하지 않습니다.

NNT · LP(A) 높음

약 28명

한 사건을 막는 데 필요한 치료 인원 (절대감소 3.7%).

NNT · LP(A) 낮음

약 40명

차이는 통계적으로 유의하지 않음 ($p=0.09$).

오늘 꼭 기억할 점

Lp(a)는 한 번 알아두면 평생 도움이 되는 위험 정보입니다

01 Lp(a)는 일반 콜레스테롤 검사에 안 나오는 **숨은 심혈관 위험인자**입니다

02 농도는 대부분 **유전으로 결정**되어 평생 일정 — 보통 **한 번만 검사**하면 됩니다

03 Lp(a)가 높을수록 **심근경색 등 관상동맥 사건** 위험이 올라갑니다
(뇌졸중과는 무관)

04 강력한 LDL 강하 치료는 **Lp(a)가 높은 낮은 모두** 심장 사건을 줄였습니다

05 "Lp(a) 높은 사람만 약효가 더 좋다"는 **아직 단정할 수 없습니다** (연구로 미확정)

→ Lp(a)가 높다면 혈압·LDL·흡연·당뇨 등 **고칠 수 있는 위험인자**를 더 철저히 관리하세요

심장을 지키는 한 걸음 더

Lp(a) 검사·심혈관 위험 관리에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

순환기내과 · 일반내과
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요